

13 - 01- L'Entretien psychiatrique - Pr. Imane ADALI

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter ce cours intitulé l'entretien psychiatrique. Je suis Imen Adeli, professeur de psychiatrie. Les objectifs de ce cours sont connaître les spécificités d'un examen psychiatrique, citer les objectifs d'un examen psychiatrique, connaître les différents domaines de la sémiologie psychiatrique, conduire un entretien psychiatrique, et enfin organiser l'observation psychiatrique sur le dossier médical.

Les circonstances de l'examen psychiatrique sont différentes par rapport aux autres spécialités. En effet, la demande de soins peut émaner soit du sujet lui-même, à l'occasion d'une souffrance psychique, une angoisse ou autre. Elle peut émaner aussi de l'entourage, à la suite de conflits familiaux ou au cas d'arrêt de traitement.

On peut aussi se retrouver en situation d'expertise médico-légale ou expertise demandée par un employeur ou un organisme d'assurance. La consultation psychiatrique nécessite un endroit calme en prévoyant un temps suffisant, environ une heure, pour un premier entretien. Si d'autres soignants sont présents, il faut en expliquer les raisons, préciser leurs fonctions et s'assurer que cela ne gêne pas le patient.

La prise de note est souvent utile vu la longueur de l'entretien. Le médecin doit penser à se présenter clairement comme étant médecin. Il fera preuve d'empathie, de respect et de chaleur envers son malade.

Une confiance mutuelle est nécessaire permettant par la suite une alliance thérapeutique. Lors du recueil des informations, il faut d'abord laisser un ton d'écoute neutre et bienveillant permettant au patient d'exprimer librement ses plaintes. Et au médecin de l'observer.

On peut relancer avec des questions ouvertes. Dans un second temps, on pose des questions fermées à la recherche d'un complément d'informations. Si possible, il faut d'abord voir le patient seul, puis voir l'entourage, et cela dans le respect du secret médical.

La rencontre avec le malade permet d'observer le patient et d'entendre ses plaintes, de rechercher des signes et des symptômes. La rencontre avec l'entourage est importante. Elle complète l'examen du patient et permet d'évaluer la qualité de l'entourage, soutenant ou déstabilisant pour le malade.

À la fin, il faut apporter un feed-back au patient ou à sa famille concernant son état, ses symptômes, le diagnostic et autres. Quoiqu'il n'ait pas toujours possible de donner une réponse définitive dès le premier entretien psychiatrique. En effet, le plus important est de reconnaître les plaintes et les difficultés du patient et d'expliquer ce que vous pensez qu'il faut faire dans l'immédiat concernant les rendez-vous, la possibilité d'hospitalisation, les bilans cliniques ou paracliniques à demander, etc.

Dans la sémiologie psychiatrique adulte, on va étudier la présentation, le comportement, les conduites sociales, les conduites instinctuelles, la pensée, les perceptions, le langage, les fonctions supérieures, l'état émotionnel, l'humeur et l'anxiété, et l'insight et jugement. Les aspects de la présentation permettent d'orienter vers un diagnostic. Dans l'aspect extérieur, on évalue l'hygiène corporelle vestimentaire, propre, sale, impurique, l'habillement, correct, adapté ou pas à l'âge, au sexe, à la situation.

L'habitus corporel qui est la manière d'entrer, de s'asseoir, de se tenir, de serrer la main. Concernant le contact, l'instantonie et la participation spontanée à l'ambiance avec un comportement adapté à la situation. L'hypersyntonie est une capacité étonnante du patient à détecter et à réagir aux attitudes d'autrui.

Contrairement à l'indifférence, le patient ne traite aucune attention à ce qui se passe autour de lui. La réticence est une attitude de méfiance, un refus volontaire d'exprimer sa pensée. Dans le ludisme, le patient se moque de l'observateur et pratique des jeux de mots.

La mimique reflète les états affectifs et émotionnels. L'hypermimie est l'exagération des mimiques. L'hypomimie est la diminution des mimiques.

La mimique est une absence totale de mimiques. La dysmimie est une mimique inadaptée au discours et à la situation. Pour l'écomimie, le sujet reproduit en miroir les mimiques de l'examineur.

Dans l'étude du comportement, on note les excès et déficits du comportement d'auteur. L'agitation est un excès de comportement d'auteur. Il s'agit d'une activité motrice, augmentée et inadaptée, contrôlable ou pas.

L'impulsion est la tendance irrésistible à la réalisation d'un acte brutal précis. Elles peuvent être soit dirigées contre des choses, exemple fugue, pyromanie, ou contre des personnes, comme les agressions et les homicides. Quant au raptus, c'est une réponse à l'instant, dans l'instant.

C'est un acte soudain, rapide, irréfléchi, en rapport avec un état émotionnel intense, comme la colère. Exemple, le raptus suicidaire. Les compulsions sont des actes répétitifs, très ritualisés, que le sujet ne peut pas s'empêcher d'accomplir, même s'il reconnaît leur caractère absurde.

Comme les vérifications, le lavage des mains. Les tics sont des mouvements anomaux, brusques, conscients, mais involontaires. Ils concernent généralement quelques muscles, le plus souvent situés au niveau du visage.

Comme le clignement des yeux, les tics de la bouche. Enfin, la parakinésie est un mouvement anormal, qui parasite ou remplace un mouvement normal. Dans le chapitre déficit moteur, on trouve le ralentissement psychomoteur, ou bradikinésie, qui correspond à une lenteur des mouvements et paroles.

La stupeur est une suspension de toute activité motrice, comme la mimique, les gestes et le langage. Le sujet paraît figé dans une immobilité totale, sans réaction aux stimuli externes. Le syndrome catatonique associe deux états qui sont en général alternants.

D'abord, le négativisme, qui est un refus de toute tentative de mobilisation. Le deuxième symptôme du syndrome catatonique est la catalepsie, qui associe, maintient à des attitudes, ce qu'on appelle le signe de l'oreiller psychique. Malgré la passivité apparente, de brusques passages à l'acte sont possibles.

Notez bien que, devant tout syndrome catatonique, il faut s'éliminer une cause organique, telle les tumeurs cérébrales. Les troubles des conduites sociales comportent fugues, voyages pathologiques, agressions, physiques, verbales ou sexuelles, tentatives de suicide, homicides, viols, etc. Il est toujours intéressant de noter le degré de conscience du sujet au moment du passage à l'acte et ses motivations.

Les troubles des conduites instinctuelles concernent l'alimentation, les conduites sexuelles et le sommeil. D'abord, les troubles des conduites alimentaires. Elles comportent restriction et excès alimentaire.

Dans les restrictions alimentaires, on note l'anorexie qui est une perte de l'appétit, l'anorexie mentale qui est un trouble spécifique correspondant à une privation volontaire de la nourriture. On passe maintenant aux excès alimentaires qui comportent hyperfagie, qui est une ingestion de trop grande quantité de nourriture au moment des horaires des repas. Quant à la boulimie, c'est une ingestion rapide et incontrôlable d'une grande quantité d'aliments.

Il s'en suit une culpabilité intense et des vomissements provoqués répétés. Dans les excès alimentaires, on note aussi la gloutonnerie qui est l'habileté à manger avec rapidité et excès tout ce qui se passe sous la main. La potomanie aussi est une absorption d'eau en très grande quantité.

Les deux grands chapitres des aberrations alimentaires sont Méricisme qui est une régurgitation et rumination du bol alimentaire Epica qui est l'absorption prolongée et répétitive d'une substance impropre à l'alimentation telle la terre ou les matières fécales. Dans le chapitre des troubles des conduites sexuelles, on va étudier d'abord les déficiences ou insuffisances sexuelles. Telles les troubles de l'érection et de l'éjaculation chez l'homme et la frigidité chez la femme.

Dans les perversions sexuelles, le plaisir est atteint par des moyens autres que le rapport sexuel normal comme l'exhibitionnisme et la nécrophilie. Dans les excès sexuels, on note une impulsion à répéter l'acte sexuel avec une fréquence inhabituelle. Les troubles du sommeil comportent Dans les troubles de la pensée, il y a trois grands chapitres.

Les troubles du cours de la pensée et les troubles de la continuité et du contenu de la pensée. Dans les troubles du cours de la pensée, il y a Le trouble de la continuité de la pensée comprend

qui est une interruption brutale du discours puis une reprise après quelques instants sur le même sujet ou sur un autre. Quant au fadine, c'est un arrêt progressif du cours de la pensée.

La parole devient lente et finie par s'épuiser. La diffluence est une dispersion anarchique de la pensée et du discours. Ne respectant ni logique ni cohérence et sans objet clairement perceptible.

La fuite des idées désigne un enchaînement très rapide des idées. Le patient passe d'une idée à une autre ne se concentrant pas sur un thème précis. Quant à la phobie, elle fait partie des troubles du contenu de la pensée.

Elle correspond à la crainte irraisonnée d'un objet ou d'une situation sans danger objectif. L'obsession est une intrusion dont la pensée d'une idée envahissante est répétitive et qui est source d'anxiété. Les idées de référence correspondent à une conviction que certains éléments de l'environnement, tels la télévision, les journaux, les médias, envoient des signes destinés au patient.

La pensée magique est une forme de la pensée qui s'attribue le pouvoir de réaliser ou d'empêcher des événements. Le rationalisme morbide est un raisonnement pseudologique. Le délire est une croyance en une idée erronée avec conviction inébranlable et ne faisant pas partie des croyances culturelles du sujet.

Le délire se caractérise par son mécanisme, son thème et la systématisation. Le délire se caractérise aussi par sa congruence ou pas à l'humeur, le vécu du sujet et son ancienneté. Ce tableau illustre un thème délirant avec ses différentes caractéristiques.

On arrive au chapitre des troubles de la perception. Il existe plusieurs formes, notamment les hallucinations. Les hallucinations sont des perceptions sans objet à percevoir.

On distingue les hallucinations psychosensorielles, telles les hallucinations auditives, visuelles, gustatives, olfactives ou sénestésiques, et les hallucinations attraps psychiques sous forme d'une image mentale. Quant à la déréalisation, c'est une perte de sentiments, de réalité et de familiarité de l'environnement. Le patient a des sentiments d'étrangeté de l'environnement.

Les choses apparaissent artificielles et les personnes sont perçues comme bizarres. Quant à la dépersonnalisation, c'est un syndrome clinique complexe lié aux sentiments éprouvés par certains sujets de n'être plus eux-mêmes. Sentiments de dédoublement ou de modification de soi, d'anéantissement psychique et autres.

Le syndrome d'automatisme mental dit de Clairambeau est une conviction délirante de ne plus être maître de sa volonté et d'être influencé par une force étrangère qui dirige ses actes, sa pensée et ses perceptions. On me fait faire des choses ou on me fait dire des choses. Le langage n'est que le reflet de la pensée.

Le débit verbal peut être accéléré, ce qu'on appelle tachyphémie ou ralenti, appelé bradyphémie. Le mutisme correspond à une absence totale ou partielle de la parole. L'étude du langage concerne aussi la sémantique, la grammaire, syntaxe et style et les productions anormales du langage.

Les troubles de défonction supérieure concernent la conscience, la vigilance, l'attention, la concentration, l'orientation et la mémoire. La conscience concerne le soi, sa personne et le monde et la conscience de l'intégrité physique et psychique. La vigilance est une mesure qualitative et quantitative de l'élé.

L'attention correspond à la capacité à focaliser ses perceptions vers un stimulus externe ou interne. L'orientation est la capacité de se repérer dans les quatre sphères, personnes, lieux, temps et contexte. Les troubles amnésiques sont l'amnésie qui est une capacité de fixer, de stocker ou de restituer une information à court ou à long terme.

L'hypermnésie est un état de libération amnésique avec irruption de bouffée de souvenirs. Quant aux paramnésies, ce sont des productions imaginaires prises pour des souvenirs. Dans les troubles de l'affectivité, on trouve l'hyperémotivité qui est une tendance à éprouver des réactions émotionnelles exagérées par rapport à la situation.

Le défaut d'émotivité correspond à l'absence d'expression émotionnelle. Quant à l'émotivité inadéquate, c'est une absence d'harmonie entre le discours ou la situation et l'affect exprimé. Les troubles de l'humeur englobent l'humeur dépressive qui est une vision pessimiste du monde et du soi.

L'humeur expansive où il y a une vision heureuse du monde avec euphorie sans limite. Quant à la timide, elle correspond à une absence de tout affect ou sentiment. Les troubles anxieux sont phobiques, c'est une anxiété fixée sur un sujet ou une situation.

Obsessionnels, où l'anxiété est fixée sur une idée. Hypochondriaques, l'anxiété est fixée sur la santé. Et traumatiques, qui correspond à une revivance d'un traumatisme conscient.

L'insight correspond à la conscience des troubles et compréhension des causes et du sens de ces troubles. Le jugement est la capacité à sélectionner des buts appropriés et à trouver et utiliser des moyens appropriés et socialement acceptables pour les atteindre. Comment organiser votre observation sur le dossier médical ? D'abord, il faut préciser l'identité et les données démographiques du patient.

Son nom, son âge, son niveau économique, social, sa profession, son statut marital et autres. On détermine la plainte principale ou ce qu'on appelle le motif de consultation du patient. On note aussi l'histoire de l'épisode actuel, ses facteurs déclenchants, la date de début, le mode de début, l'évolution, la durée, les symptômes et signes, leurs effets sur le sujet et sur l'environnement.

On note aussi l'histoire de la maladie, le nombre d'hospitalisations, de consultations, le traitement reçu et l'évolution. Il faut préciser les antécédents psychiatriques, médico-chirurgicaux, toxiques, judiciaires du patient. L'histoire personnelle ou la biographie est un élément important à explorer au cours de l'entretien.

Naissance et première enfance, grossesse et naissance désirée, notion d'abandon, de séparation. L'enfance et l'adolescence en termes d'apprentissage et scolarité, relation avec les pères et la vie adulte, sociale, affective et sexuelle. Il faut aussi préciser l'histoire familiale, surtout en termes de pathologie psychiatrique, d'addiction et traumatisme.

On explore aussi l'état mental actuel et la personnalité. Des questionnaires, des examens complémentaires peuvent être utilisés en fonction du contexte clinique. La conclusion est un résumé des principaux symptômes que présente le malade, à partir duquel on va évoquer des diagnostics.

La conduite à tenir est en fonction du diagnostic évoqué. A la fin, l'évolution et le pronostic de la maladie qui dépendent du type, de pathologie psychiatrique et de sa sévérité. Je vous remercie pour votre attention.